

	miếng. Tránh những phản ứng này bằng cách tạm thời ngưng dùng thuốc ức chế ACE trước mỗi lần ly trích LDL. Suy gan Triển triển khi sử dụng thiazide cho bệnh nhân suy giảm chức năng gan hoặc bệnh gan tiến triển, vì những thay đổi mô của cân bằng nước và điện giải có thể dẫn đến hôn mê gan. Hiếm khi thuốc ức chế ACE có liên quan đến hội chứng khởi phát bằng tình trạng vàng da ở mắt hoặc viêm gan và tiến triển thành hoại tử tối cấp và (đôi khi) gây tử vong. Chưa rõ cơ chế của hội chứng này. Bệnh nhân dùng lisinopril/hydrochlorothiazide khi phải phẫu thuật vì vàng da hoặc tăng enzym gan rõ rệt nên ngưng dùng thuốc và phải được theo dõi y tế thích hợp. Phẫu thuật gây mê Ở những bệnh nhân đang trải qua cuộc phẫu thuật lớn hoặc trong khi gây mê bằng các thuốc gây mê huyết áp, lisinopril có thể ức chế sự tạo thành angiotensin II từ phát do phóng thích renin bù trừ. Nếu hạ huyết áp xảy ra và được nghĩ là do cơ chế này, có thể điều chỉnh bằng cách tăng thể tích tuần hoàn. Ảnh hưởng lên chuyển hóa và nội tiết Điều trị bằng thuốc ức chế ACE và thiazide có thể làm giảm khả năng dung nạp glucose. Có thể cần chỉnh liều các thuốc trị đái tháo đường, bao gồm cả insulin. Bệnh nhân đái tháo đường điều trị bằng thuốc hạ đường huyết đường uống hoặc insulin nên theo dõi chặt chẽ mức đường huyết trong tháng đầu điều trị với thuốc ức chế ACE. Bệnh đái tháo đường tiềm ẩn có thể biểu hiện ra trong quá trình điều trị bằng thiazide. Tăng nồng độ cholesterol và triglycerid có thể liên quan đến thuốc lợi tiểu thiazide. Điều trị bằng thiazide có thể gây tăng acid uric máu và/hoặc bệnh gút ở một số bệnh nhân. Tuy nhiên, lisinopril có thể làm tăng acid uric niệu và do đó có thể làm giảm tác dụng tăng acid uric máu của hydrochlorothiazide. Mất cân bằng điện giải Đối với bệnh nhân đang điều trị bằng thuốc lợi tiểu, nên định kỳ xác định các chất điện giải trong huyết thanh tại những khoảng thời gian thích hợp. Các thiazide, bao gồm hydrochlorothiazide, có thể gây mất cân bằng nước hoặc điện giải (hạ kali huyết, hạ natri huyết và/hoặc hạ độ giảm clo huyết). Các dấu hiệu cảnh báo mất cân bằng nước hoặc điện giải là: khô miệng, khát nước, yếu cơ, ngù lìm, buồn nôn, đau cơ hoặc co thắt cơ, mất cơ, hạ huyết áp, thiếu niệu, nhịp tim nhanh và rối loạn tiêu hóa như buồn nôn hoặc nôn. Hạ natri huyết hoặc hạ độ giảm clo huyết xảy ra ở những bệnh nhân phụ nữ khi thời tiết nóng bức. Tình trạng thiếu hụt clorid thường nhẹ và không cần điều trị. Thiazide đã được chứng minh làm tăng bài tiết magesi trong nước tiểu, có thể dẫn đến hạ magesi huyết. Thiazide có thể làm giảm bài tiết calci qua nước tiểu và làm tăng nhẹ calci huyết thanh và không liên tục. Tăng calci huyết rõ rệt có thể là dấu hiệu của cường tuyến cận giáp tiềm ẩn. Nên ngưng dùng thiazide trước khi tiến hành các xét nghiệm kiểm tra chức năng tuyến cận giáp. Tăng kali huyết Thuốc ức chế ACE có thể gây tăng kali huyết do ức chế giải phóng aldosteron. Tác dụng thường không đáng kể ở những bệnh nhân có chức năng thận bình thường. Tuy nhiên, tăng kali huyết có thể xảy ra ở những bệnh nhân suy giảm chức năng thận, đái tháo đường và/hoặc đang dùng chất bổ sung kali (bao gồm cả chất thay thế muối), thuốc lợi tiểu thẩm thấu (ví dụ spironolactone, triamterene hoặc amiloride), các thuốc khác có liên quan đến tăng kali huyết (ví dụ heparin, trimethoprim hoặc co-trimoxazole còn được biết là trimethoprim/sulfamethoxazole) và đặc biệt là thuốc đối kháng aldosteron hoặc thuốc chẹn thụ thể angiotensin. Nên sử dụng thận trọng trong thuốc lợi tiểu tiết kali và thuốc chẹn thụ thể angiotensin cho bệnh nhân đang dùng thuốc ức chế ACE, đồng thời theo dõi kali huyết thanh và chức năng thận. Đái tháo đường Ở bệnh nhân đái tháo đường đang dùng thuốc uống trị đái tháo đường hoặc insulin, nên kiểm soát chặt chẽ mức đường huyết trong tháng đầu điều trị bằng thuốc ức chế ACE. Quá mẫn/phụ mạch Phụ mạch ở mắt, tay chân, mũi, lưỡi, thanh môn và/hoặc thanh quản đã được báo cáo ít gặp ở những bệnh nhân điều trị với thuốc ức chế ACE, bao gồm lisinopril. Điều này có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong thời gian dùng thuốc. Trong trường hợp này, phải ngưng dùng lisinopril ngay và điều trị và theo dõi thích hợp để đảm bảo các triệu chứng đã hết hoàn toàn trước khi cho bệnh nhân xuất viện. Ngay cả trong trường hợp chỉ phụ lưỡi, không bị suy hô hấp, cần tiếp tục theo dõi bệnh nhân vì liệu pháp kháng histamine và corticosteroid có thể không đáp ứng đủ. Trong vài trường hợp rất hiếm đã ghi nhận từ vòng do phụ mạch liên quan đến phụ mạch thanh quản hoặc phụ lưỡi. Bệnh nhân bị phụ lưỡi, thanh môn hoặc thanh quản, có khả năng bị tác nhân đường hô hấp, đặc biệt là những người có tiền sử phẫu thuật đường hô hấp. Trong trường hợp này, nên áp dụng các biện pháp cấp cứu ngay lập tức. Có thể bao gồm tiêm adrenaline vào/hoặc duy trì thông thoáng đường hô hấp. Bệnh nhân nên được theo dõi y khoa cẩn thận cho đến khi các triệu chứng được giải quyết hoàn toàn và ổn định. Thuốc ức chế ACE có tỷ lệ gây phụ mạch ở bệnh nhân da đen cao hơn so với bệnh nhân màu da khác. Bệnh nhân có tiền sử phụ mạch không liên quan đến điều trị bằng thuốc ức chế ACE có thể tăng nguy cơ phụ mạch khi dùng thuốc ức chế ACE. Chống chỉ định sử dụng đồng thời thuốc ức chế ACE với sacubitril/valsartan do làm tăng nguy cơ phụ mạch. Điều trị bằng sacubitril/valsartan không được bắt đầu sớm hơn 36 giờ sau liều lisinopril/hydrochlorothiazide cuối cùng. Điều trị bằng lisinopril/hydrochlorothiazide không được bắt đầu sớm hơn 36 giờ sau liều cuối cùng của sacubitril/valsartan. Sử dụng đồng thời thuốc ức chế ACE với racecadotril, thuốc ức chế mTOR (ví dụ sirolimus, everolimus, temsirolimus) và vildagliptin có thể dẫn đến tăng nguy cơ phụ mạch (ví dụ sưng đường hô hấp hoặc lưỡi, có hoặc không kèm theo suy hô hấp). Cần thận trọng khi bắt đầu dùng racecadotril, thuốc ức chế mTOR (ví dụ sirolimus, everolimus, temsirolimus) và vildagliptin ở bệnh nhân đã dùng thuốc ức chế ACE. Ở những bệnh nhân dùng thiazide, phản ứng quá mẫn có thể xảy ra cho dù bệnh nhân có tiền sử dị ứng hoặc hen phế quản hay không. Bệnh nhân ban đỏ do thuốc có thể trầm trọng hay bội phát đã được báo cáo khi dùng thiazide. Giải mẫn cảm Bệnh nhân dùng thuốc ức chế ACE trong quá trình điều trị giải mẫn cảm (ví dụ nọc độc loài hymenoptera) có phản ứng phản vệ kéo dài. Ở những bệnh nhân này, phản ứng phản vệ không xảy ra khi tạm thời ngưng dùng thuốc ức chế ACE nhưng đã xuất hiện trở lại khi vô tình dùng lại thuốc. Giảm bạch cầu trung tính/mất bạch cầu hạt Giảm bạch cầu trung tính/mất bạch cầu hạt, giảm tiểu cầu và thiếu máu đã được báo cáo ở những bệnh nhân dùng thuốc ức chế ACE. Ở những bệnh nhân có chức năng thận bình thường và không có các yếu tố gây biến chứng khác, hiếm khi xảy ra giảm bạch cầu. Tình trạng giảm bạch cầu trung tính và mất bạch cầu hạt có thể hồi phục sau khi ngưng dùng thuốc. Nên thận trọng khi sử dụng lisinopril ở những bệnh nhân có bệnh lý mạch collagen, đang điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch, allopurinol hoặc procainamide, hoặc có sự kết hợp các yếu tố gây biến chứng này, đặc biệt ở bệnh nhân bị suy giảm chức năng thận trước đó. Một số bệnh nhân bị nhiễm trùng nghiêm trọng, không đáp ứng với trị liệu kháng sinh tích cực. Khi dùng lisinopril cho những bệnh nhân này, nên theo dõi định kỳ số lượng bạch cầu và hướng dẫn bệnh nhân báo cáo bất kỳ dấu hiệu nhiễm trùng nào. Chống tác Thuốc ức chế ACE gây ra tỷ lệ phụ mạch ở bệnh nhân da đen cao hơn so với bệnh nhân màu da khác. Cũng như các thuốc ức chế ACE khác, lisinopril có thể ít có tác dụng hạ huyết áp ở bệnh nhân da đen so với các nhóm bệnh nhân khác, có thể do trạng thái renin thấp chiếm tỷ lệ cao ở nhóm bệnh nhân da đen tăng huyết áp. Ho Ho đã được ghi nhận khi sử dụng thuốc ức chế ACE. Điển hình là ho khan, kéo dài và tự hết khi ngưng thuốc. Ho do thuốc ức chế ACE phải được xem xét khi chẩn đoán phân biệt nguyên nhân gây ho. Lithi Nhìn chung, không khuyến cáo dùng phối hợp thuốc ức chế ACE và lithi. Xét nghiệm doping Hydrochlorothiazide trong thuốc có thể cho kết quả phân tích dương tính trong xét nghiệm doping. Thai kỳ Không nên dùng thuốc ức chế ACE trong thời kỳ mang thai. Trừ khi cần thiết phải tiếp tục điều trị với thuốc ức chế ACE, bệnh nhân có kế hoạch mang thai nên được chuyển sang dùng thuốc điều trị tăng huyết áp khác đã được ghi nhận an toàn khi dùng trong thai kỳ. Khi xác định có thai, ngưng sử dụng thuốc ức chế ACE ngay và chuyển sang liệu pháp điều trị thay thế khác nếu thích hợp. Trần dịch màng mang, cận thị cấp tính và tăng nhãn áp góc đóng thứ phát Sulfonamide hoặc các thuốc là dẫn xuất sulfonamide có thể gây ra phản ứng đặc trưng dẫn đến tran dịch màng mang với triệu chứng thị giác, cận thị thoáng qua và tăng nhãn áp góc đóng cấp tính. Các triệu chứng bao gồm khởi phát cấp tính của giảm thị lực hoặc đau mắt thường xảy ra trong vài giờ đến vài tuần sau khi bắt đầu dùng thuốc. Tăng nhãn áp góc đóng cấp tính nếu không được điều trị có thể dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn. Điều trị cơ bản là nên ngưng thuốc càng nhanh càng tốt. Có thể cần khăn điều trị nội khoa hoặc phẫu thuật nếu vẫn không kiểm soát được nhãn áp. Các yếu tố nguy cơ phát triển bệnh tăng nhãn áp góc đóng cấp tính có thể bao gồm tiền sử dị ứng với sulfonamide hoặc penicillin. Manitol Lisipus HCT 10/12.5 có chứa manitol, có thể cho tác dụng nhuận tràng nhẹ.	
9.	Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú Phụ nữ có thai Thuốc ức chế ACE Không khuyến cáo dùng các thuốc ức chế ACE trong ba tháng đầu của thai kỳ. Chống chỉ định dùng các thuốc ức chế ACE trong quý thứ hai và thứ ba của thai kỳ. Bảng chứng dịch tế học về nguy cơ gây quái thai sau khi tiếp xúc với thuốc ức chế ACE trong ba tháng đầu của thai kỳ chưa được xác định; tuy nhiên không thể loại trừ cơ sở gia tăng nhỏ về nguy cơ. Trừ khi cần thiết phải tiếp tục điều trị với thuốc ức chế ACE, bệnh nhân có kế hoạch mang thai nên được chuyển sang dùng thuốc điều trị tăng huyết áp khác đã được ghi nhận an toàn khi dùng trong thai kỳ. Khi xác định có thai, ngưng sử dụng thuốc ức chế ACE ngay và chuyển sang liệu pháp điều trị thay thế khác nếu thích hợp.	
10.	Phụ nữ cho con bú Thuốc ức chế ACE Không khuyến cáo dùng các thuốc ức chế ACE trong ba tháng đầu của thai kỳ. Chống chỉ định dùng các thuốc ức chế ACE trong quý thứ hai và thứ ba của thai kỳ. Bảng chứng dịch tế học về nguy cơ gây quái thai sau khi tiếp xúc với thuốc ức chế ACE trong ba tháng đầu của thai kỳ chưa được xác định; tuy nhiên không thể loại trừ cơ sở gia tăng nhỏ về nguy cơ. Trừ khi cần thiết phải tiếp tục điều trị với thuốc ức chế ACE, bệnh nhân có kế hoạch mang thai nên được chuyển sang dùng thuốc điều trị tăng huyết áp khác đã được ghi nhận an toàn khi dùng trong thai kỳ. Khi xác định có thai, ngưng sử dụng thuốc ức chế ACE ngay và chuyển sang liệu pháp điều trị thay thế khác nếu thích hợp.	
11.	Phụ nữ cho con bú Thuốc ức chế ACE Không khuyến cáo dùng các thuốc ức chế ACE trong ba tháng đầu của thai kỳ. Chống chỉ định dùng các thuốc ức chế ACE trong quý thứ hai và thứ ba của thai kỳ. Bảng chứng dịch tế học về nguy cơ gây quái thai sau khi tiếp xúc với thuốc ức chế ACE trong ba tháng đầu của thai kỳ chưa được xác định; tuy nhiên không thể loại trừ cơ sở gia tăng nhỏ về nguy cơ. Trừ khi cần thiết phải tiếp tục điều trị với thuốc ức chế ACE, bệnh nhân có kế hoạch mang thai nên được chuyển sang dùng thuốc điều trị tăng huyết áp khác đã được ghi nhận an toàn khi dùng trong thai kỳ. Khi xác định có thai, ngưng sử dụng thuốc ức chế ACE ngay và chuyển sang liệu pháp điều trị thay thế khác nếu thích hợp.	
12.	Tác dụng không mong muốn của thuốc Lisinopril Thường gặp (1/100 < ADR < 1/10) - Tâm thần và thần kinh: Chóng mặt, đau đầu, ngất. - Tim và mạch máu: Tác động tư thế (bao gồm hạ huyết áp thể đứng). - Hô hấp, ngực và trung thất: Ho. - Tiểu hoa: Tiểu chảy, nôn. - Thận và tiết niệu: Rối loạn chức năng thận. Ít gặp (1/1.000 < ADR < 1/100) - Tâm thần và thần kinh: Dị cảm, chóng mặt, rối loạn vị giác, rối loạn giấc ngủ, thay đổi tâm trạng, các triệu chứng trầm cảm. - Tim và mạch máu: Nhồi máu cơ tim hoặc tai biến mạch máu não, có thể thứ phát do hạ huyết áp quá mức ở những bệnh nhân có nguy cơ cao, đánh trống ngực, nhịp tim nhanh, hiện tượng Reynaud. - Hô hấp, ngực và trung thất: Viêm mũi. - Tiểu hoa: Buồn nôn, đau bụng, khó tiêu. - Gan-mật: Tăng enzym gan và bilirubin. - Da và mô dưới da: Phát ban, ngứa. - Sinh sản và vú: Liệt dương. - Toàn thân và tại chỗ dùng thuốc: Suy nhược, mệt mỏi. - Các chỉ số xét nghiệm: Tăng ure máu, tăng creatinin huyết thanh, tăng kali huyết. Hiếm gặp (1/10.000 < ADR < 1/1.000) - Máu và bạch huyết: Giảm hemoglobin, giảm hematocrit. - Nội tiết: Hội chứng tiết hormon chống bài niệu không thích hợp (SIADH). - Tâm thần và thần kinh: Rối loạn tâm thần, rối loạn loạn giác. - Tiểu hoa: Khô miệng. - Da và mô dưới da: Quai mẫn/phụ thân kinh: Phụ mạch ở mắt, tay chân, mũi, lưỡi, thanh môn và/hoặc thanh quản, mày đay, rụng tóc, vẩy nến. - Thận và tiết niệu: Ure huyết, suy thận cấp. - Sinh sản và vú: Vô tư ở nam giới. - Các chỉ số xét nghiệm: Hạ natri huyết. Rất hiếm gặp (ADR > 1/10.000) - Máu và bạch huyết: Suy tủy xương, thiếu máu, giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu, giảm bạch cầu trung tính, mất bạch cầu hạt, thiếu máu tán huyết, bệnh hạch bạch huyết, bệnh tự miễn. - Chuyển hóa và dinh dưỡng: Hạ đường huyết. - Hô hấp, ngực và trung thất: Co thắt phế quản, viêm xoang, viêm phế nang dị ứng/viêm phổi tăng bạch cầu ái toan. - Tiểu hoa: Viêm tủy, phụ mạch ruột. - Da và mô dưới da: Đỏ mủ hôi, bệnh pemphigus, hoại tử biểu bì nhiễm độc, hội chứng Stevens-Johnson, hồng ban da dạng, u lympho giả trên da. - Thận và tiết niệu: Thiếu niệu/vô niệu. - Chưa rõ tần suất (không thể ước tính từ các dữ liệu có sẵn) - Miền dịch: Phản ứng phản vệ/giả phản vệ. - Tâm thần và thần kinh: Ảo giác. - Tim và mạch máu: Đờ ỉa. Hydrochlorothiazide - Chưa rõ tần suất (không thể ước tính từ các dữ liệu có sẵn) - Nhiễm khuẩn và nhiễm ký sinh trùng: Viêm tuyến tiền liệt. - U liên tính, ác tính và không xác định (bao gồm u nang và polyp): Ung thư da không hắc tố (ung thư biểu mô tế bào đáy và ung thư biểu mô tế bào vảy). - Máu và bạch huyết: Giảm bạch cầu, giảm bạch cầu trung tính/mất bạch cầu hạt, giảm tiểu cầu, thiếu máu bất sản, thiếu máu tán huyết, suy tủy xương. - Chuyển hóa và dinh dưỡng: Chấn ăn, tăng đường huyết, glucose niệu, tăng acid uric huyết, mất cân bằng điện giải (bao gồm hạ natri huyết, hạ kali huyết, hạ clo huyết và hạ magesi huyết), tăng cholesterol và triglycerid, bệnh gút. - Tâm thần: Bồn chồn, trầm cảm, rối loạn giấc ngủ. - Thận kinh: Chấn ăn, dị cảm, chóng mặt. - Mắt: Chứng thấy sắc vàng, nhìn mờ thoáng qua, cận thị cấp tính và tăng nhãn áp góc đóng cấp tính, tran dịch màng mạch. - Tai và tai trong: Chóng mặt. - Tim: Hạ huyết áp tư thế. - Mạch: Viêm mạch hoại tử (viêm mạch, viêm mạch máu dưới da). - Hô hấp, ngực và trung thất: Suy hô hấp (bao gồm viêm phổi và phụ phổi). - Tiểu hoa: Kích ứng dạ dày, tiểu chảy, táo bón, viêm tụy. - Da và mô dưới da: Viêm da (viêm da ở mắt trong gan). - Da và mô dưới da: Phản ứng quá mẫn, phát ban, lupus ban đỏ hệ thống, phản ứng da giống lupus ban đỏ, lupus ban đỏ tái phát, mày đay, phản ứng phản vệ, hoại tử biểu bì nhiễm độc. - Cơ xương, mô liên kết và xương: Co thắt cơ, yếu cơ. - Thận và tiết niệu: Rối loạn chức năng thận, viêm thận kẽ. - Toàn thân: Sốt, suy nhược.	
13.	Quá liều và cách xử trí Triệu chứng Các triệu chứng liên quan đến quá liều các thuốc ức chế ACE có thể bao gồm hạ huyết áp, sốc tuần hoàn, rối loạn điện giải, suy thận, tăng thông khí, nhịp tim nhanh, đánh trống ngực, nhịp tim chậm, chóng mặt, lo lắng và no. Xử trí Triển triển mạch dùng dịch muối sinh lý. Nếu hạ huyết áp xảy ra, bệnh nhân nên được đặt ở tư thế nằm ngửa. Nếu có sẵn, có thể xem xét việc truyền angiotensin II và/hoặc tinh thể mạch catecholamin. Nếu mới uống, dùng các biện pháp giúp thải trừ lisinopril (như gây nôn, rửa dạ dày, dùng chất hấp phụ và natri sulfat). Lisinopril có thể được loại bỏ khi tuần hoàn chung bằng thẩm tách máu. Dùng máy điều hòa nhịp tim khi nhịp tim chậm do đề kháng với việc điều trị. Theo dõi thường xuyên các dấu hiệu sinh tồn, nồng độ các chất điện giải và creatinin trong huyết thanh. Các triệu chứng thêm vào của quá liều hydrochlorothiazide như tăng bài niệu, suy giảm ý thức (bao gồm cả tình trạng hôn mê), co giật, liệt, loạn nhịp tim và/hoặc hạ đường huyết có thể tăng động chống tăng huyết áp của thiazide. Thiazide không ảnh hưởng trên huyết áp bình thường.	
14.	Đặc tính dược lực học Nhóm dược lý: Thuốc tác dụng trên hệ renin - angiotensin; thuốc ức chế ACE và thuốc lợi tiểu. Mã ATC: C09BA03. Lisinopril là thuốc ức chế enzym chuyển angiotensin (ACE). ACE là một peptidyl dipeptidase xúc tác phản ứng chuyển angiotensin I thành angiotensin II có tác dụng co mạch. Angiotensin II còn kích thích sự tiết aldosteron có vai trò tương tự. Tác động co mạch của lisinopril trên bệnh tăng huyết áp và suy tim chủ yếu do ức chế hệ thống renin-angiotensin-aldosteron. Việc ức chế ACE làm giảm angiotensin II trong huyết tương dẫn đến giảm hoạt tính co mạch và giảm tiết aldosteron. Hydrochlorothiazide là thuốc lợi tiểu và hạ huyết áp. Thiazide tác động lên cơ chế tái hấp thu các chất điện giải ở ống thận, làm tăng bài tiết natri và clorid với lượng hấp xấp xỉ bằng nhau. Tăng bài tiết natri niệu cũng đi kèm với sự mất kali và bicarbonat. Chưa biết cơ chế tác động chống tăng huyết áp của thiazide. Thiazide không ảnh hưởng trên huyết áp bình thường.	
15.	Đặc tính dược động học Lisinopril hấp thu chậm và không hoàn toàn sau khi uống. Sự hấp thu rất khác nhau giữa các cá thể, khoảng từ 6 - 60%, nhưng trung bình khoảng 25% liều dùng được hấp thu. Lisinopril là một diacid có sẵn hoạt tính và không cần được chuyển hóa trong cơ thể. Nồng độ đỉnh trong huyết tương đạt được sau khoảng 7 giờ. Lisinopril liên kết không đáng kể với protein huyết tương. Thuốc được thải trừ qua nước tiểu dưới dạng không biến đổi. Thời gian bán thải tích lũy sau khi uống nhiều liều ở người bệnh có chức năng thận bình thường là 12 giờ. Lisinopril được loại bỏ bằng thẩm tách máu. Hydrochlorothiazide được hấp thu khá nhanh qua đường tiêu hóa. Thuốc có sinh khả dụng khoảng 65 - 70%. Thời gian bán thải trong huyết tương khoảng 5 - 15 giờ và ưu tiên gắn kết vào hồng cầu. Thuốc được thải trừ chủ yếu qua nước tiểu dưới dạng không đổi. Hydrochlorothiazide qua được hàng rào nhau thai và được bài tiết vào sữa mẹ.	
16.	Quy cách đóng gói Ví 10 viên, Hộp 3 vỉ. Ví 10 viên, Hộp 6 vỉ.	
17.	Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc	
17.1.	Điều kiện bảo quản Bảo quản trong bao bì kín, nơi khô, tránh ánh sáng. Nhiệt độ không quá 30°C.	
17.2.	Hạn dùng 36 tháng kể từ ngày sản xuất.	
17.3.	Tiêu chuẩn chất lượng TCCS.	
18.	Thên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc	



Công ty TNHH LD Stellapharm - Chi nhánh 1
Số 40 đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore,
P. An Phú, Tp. Thuận An, T. Bình Dương, Việt Nam
ĐT: (+84 274) 3767 470 Fax: (+84 274) 3767 469